11. EL CORAZÓN : RESUMEN E IMPLICACIÓN PRÁCTICA

DURACIÓN : 11:02 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora la importancia del corazón en el desarrollo embrionario, posicionándolo como el punto de encuentro de las fuerzas vitales entre el espermatozoide y el óvulo. Se aprende cómo el corazón se forma dentro de la línea primitiva, interactuando con estructuras clave como el tubo neural y el mesodermo. También se abordan los conceptos de diástole y sístole, con especial atención a cómo estos movimientos pueden observarse e integrarse en la práctica osteopática. Los profesionales aprenderán a utilizar fulcros embrionarios para revitalizar y equilibrar los sistemas cardíaco y cerebral, afinando su enfoque a través de puntos de apoyo relevantes.

EL CORAZÓN: RESUMEN E IMPLICACIONES PRÁCTICAS

EL CORAZÓN: PUNTO DE ENCUENTRO SIMBÓLICO

El **corazón** es considerado el punto de encuentro simbólico entre el **espermatozoide** y el **óvulo**. Es aquí donde se establece un **patrón fundamental**, manifestándose incluso en un plano de polaridad.



FIG. — Embrión bicelular

APARICIÓN Y DESARROLLO TEMPRANO

La emergencia del corazón es particularmente interesante a nivel de la **línea primitiva**.

Es el vestigio bajo S2, extremo terminal de la **notocorda** y lugar de la sensación.

Lo abordamos en su entorno facial y su movimiento de desarrollo. Se reintegrará en la **neurulación secundaria** durante el cierre y la formación de la pelvis menor.

La neurulación secundaria es ese espacio entre el **filum terminal** y el **brote caudal**, implicando un crecimiento diferencial del **tubo neural** en relación con el **endoblasto** anterior, con una apertura de la luz.

El endoblasto anterior es el endoblasto embrionario, pero aquí, a nivel **mesoblástico** y también a nivel del corazón.

En esta ola con la línea primitiva, que termina en S2, una **fuerza cardíaca primitiva** ya está presente. La localización presunta en el epiblasto forma parte del potencial del corazón, es la localización más temprana identificada.

Las **células cardiogénicas** se encuentran a nivel del epiblasto, en la capa presuntiva del epiblasto, incluso antes de la formación del mesodermo.

Volveremos a encontrar esta lámina presuntiva. Un movimiento de crecimiento es seguido de una congestión, luego de la integración y el encuentro de los dos tubos, organizada desde la periferia por la **cavidad amniótica**. El tubo neural, el tubo cardíaco y la integración del diafragma concurren en la formación del corazón.

Esto ocurre al mismo tiempo que el cierre del tubo neural y la integración del **celoma** externo en celoma interno.

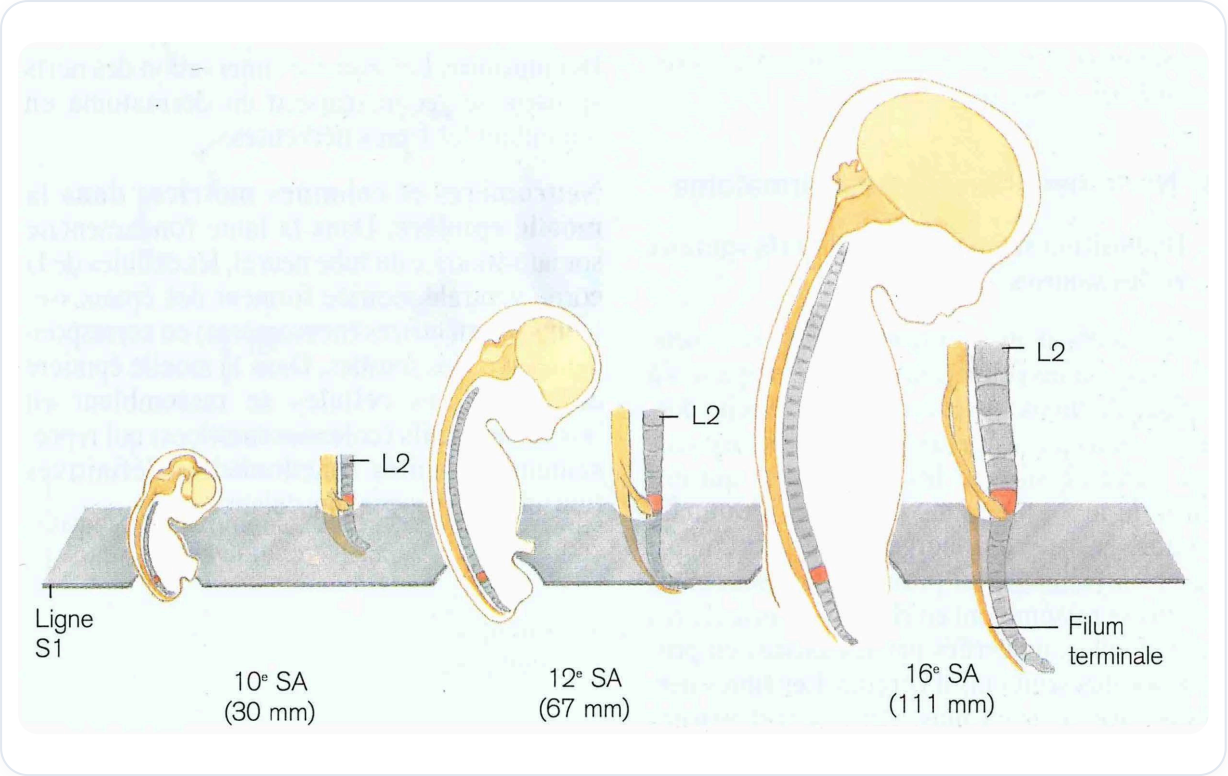


FIG. — Crecimiento relativo de la médula espinal

LA LÍNEA PRIMITIVA Y EL FULCRO CARDÍACO

El lugar más temprano identificable es la línea primitiva.

La notocorda termina a nivel de S2. El espacio entre S2 y el extremo de la línea primitiva contiene el vestigio de la línea primitiva.

El **fulcro embrionario** del corazón está en el cóccix.

El corazón se pone entonces en una postura más bien **diastólica**, buscando energía y volumen. Desciende en su movimiento.

El corazón también presenta un fulcro, es decir, un punto de origen, que puede manifestar de manera diferente.

MOVIMIENTOS Y ESTRUCTURAS CARDÍACAS

Se establece un movimiento entre el **cerebro**, con la **cefalización**, y el corazón, la **cardialización**, permitiendo su encuentro.

Al mismo tiempo, los dos tubos endocárdicos se encuentran en la línea media. Sigue el **looping** del corazón, luego la formación del **sinusoide cardíaco** y del **cayado aórtico**, con los grandes vasos.

El **eje de la vena cava** sirve de referencia.

Es importante observar si el corazón se expresa en un plano sistólico o diastólico. Facialmente, busca más la diástole o la sístole.

En relación con el ilíaco, busca mucho más la **horizontalidad**, lo que indica un movimiento diastólico. Podemos llegar a buscar el **pulso aórtico**.

DESARROLLO CEREBRAL Y CARDÍACO

Integraremos progresivamente el desarrollo del cerebro en relación con el movimiento de desarrollo.

El primer movimiento de desarrollo del cerebro fue la **expansión**. Esta expansión dependía del **eje longitudinal** o del **eje mesentérico**. Depende de la integración vitelina, cuyo vestigio se encontrará en el eje mesentérico.

Luego, otro nivel importante para la nutrición es el sistema entre el **bazo** y el **hígado**, con el retorno al corazón a través de la **vena cava**. Luego, la información aórtica se manifestará por cuatro o dos puertas de entrada: carotídea, por encima, por debajo, vertebral.

Así integramos el desarrollo del cerebro con el corazón y el sistema mesentérico. Al trabajar en el cerebro, observamos qué campo debe abrirse. Podemos afinar las percepciones para determinar las zonas a trabajar, por ejemplo, en el sistema carotídeo en relación con el corazón.

Esto se puede hacer dando simples puntos de apoyo, ya sean fulcros embrionarios o puntos de apoyo en la construcción, para redinamizar la fuerza de regeneración.

Un fulcro es un punto de emergencia. Toda la fuerza de desarrollo, como la integración de la **vesícula vitelina** en una arteria (un vestigio de la vía de desarrollo y no un fulcro embrionario), se sitúa entre el fulcro y la finalidad.

Empezamos a percibir el juego en el que nos vamos a involucrar, porque trabajaremos en arterias específicas. El objetivo es devolver la **plena homeostasis**, la plena vitalidad, la plena salud.

ORIGEN DEL FULCRO Y ONDA MESODÉRMICA

Tocaré el origen de su fulcro, que se encuentra de forma indirecta a nivel coccígeo, y luego se integrará poco a poco en su sistema por el movimiento de desarrollo del **manotococcus**, esa ola con esa aspiración a nivel del mesodermo.

Es una información que reestructura, redinamiza, devuelve la fuerza al tejido, devuelve la función.

El desarrollo de las fuerzas embrionarias permite el desarrollo de la función principal del sistema.

EL PAPEL CENTRAL DEL DIAFRAGMA

El gran maestro para todo esto será el **diafragma**. Se trata de apoyarse bien en este diafragma con tres niveles:

- **Cavidad amniótica** en el plano transversal
- **Torácica**
- **Abdominal**

Esta integración del celoma, y al mismo tiempo la integración del cerebro, el corazón, el diafragma, la parte posterior del peritoneo, para volver al **perineo** y devolver por esta basculación del hígado todo el cierre de mi línea alba, que dará toda la información **urogenital**.

LA LÍNEA ALBA Y EL SISTEMA UROGENITAL

Así es como se va a formar. La **línea alba** representa la integración completa del plano urogenital, es su historia final.

En esta línea alba, podremos buscar concentraciones de tiempo cristalizadas, porque es una línea de probabilidad en relación con el **eritrocito**, la formación de los glóbulos, por lo tanto un futuro, donde el plano de la **cópula** es también tu futuro.

En el momento de la salida, se produce el estiramiento, y así es como todo el sistema genital externo e interno se integrará en este plano de la línea alba anterior. Termina para reconstruir.

En un plano de los glóbulos, la **eritrocitosis** o la **gonocitosis** avanzan. En un momento dado, el embrión hace un movimiento. Hay una línea de iniciación en la vida. En el momento del nacimiento, hay que abrir esta línea, la línea alba, e iniciarse en la vida.

FULCROS EMBRIONARIOS Y SISTEMA ARTERIAL

La idea será devolver los justos **fulcros embrionarios**. El sistema arterial debe ser visto como un **pulpo**.

Mañana, detallaremos el sistema arterial a nivel del rostro, porque es una puerta de acceso trófico a nivel del cerebro. Habrá que comprender el desarrollo del sistema carotídeo y del sistema vertebral.

Estos dos sistemas, con toda la información sobre el **polígono de Willis** y las **arterias cerebrales** anterior, media, posterior, así como los senos o las válvulas (de Brechet o de Thierry Goïdienne, etc.), son espacios de equilibrio.

EQUILIBRIO VASCULAR CEREBRAL

Necesitamos un equilibrio entre el aporte vascular y el retorno venoso. Ahora se sabe que existe un **sistema linfático** en el cerebro.

Para eliminar los excesos, algunos pueden tener una **congestión linfática** o venosa a nivel del cerebro. Se observa en personas un poco hinchadas, un poco edematosas. El retorno no se produce.

Entonces es necesario un trabajo de reequilibrio a nivel venoso, ya sea a nivel de la **vena cava superior** o inferior. Esto es importante para evitar las congestiones, especialmente a nivel de los oídos, y todo lo que no puede evacuarse.

POSTURA TERAPÉUTICA

Me posiciono bien a nivel del cóccix y del corazón. Se puede visualizar el **ángulo de Louis**, el tronco vascular de tipo aórtico pulmonar.

El corazón está en el **eje longitudinal**. Solo una parte de él está dilatada hacia la izquierda, con una fase de desarrollo en su punta del corazón a la izquierda.

Usted se posicionará en el plano longitudinal del corazón. Al dar un fulcro aquí y un punto de apoyo en el corazón, mi atención está en el espacio, neutra, y dejamos que el sistema se organice.